苏州宜联生物医药有限公司

临床监查员操作手册

(CRA MANUAL)

2026.10

一、目的

本 CRA 使用手册旨在统一监查员（CRA，Clinical Research Associate）对临床试验法规、项目流程、岗位操作的理解，明确 CRA 岗位职责、工作标准、操作流程与合规要求。帮助 CRA 准确掌握 2026 版 GCP、ICH-E6 (R3) 及项目特定要求，规范监查全流程工作行为；降低因人员经验差异带来的试验质量风险，保障试验参与者权益与安全，确保临床试验数据真实、准确、完整、可追溯；同时作为新人培训、在岗人员查阅参考的工具，统一工作口径，减少执行偏差，保障临床试验项目高质量、合规推进。



目录

一、目的 2

1. 研究中心的筛选 7

3. 临床试验监查（临床试验质量管理） 28

3.1 知情同意监查要点 28

3.2 方案依从性的监查要点 32

3.3 原始数据核查 37

3.4 试验药物的监查要点 47

3.5 不良事件/严重不良事件的监查要点 51

3.6 合并用药的监查要点 57

3.7 安全性报告提交，递交常见问题 61

4. 临床试验监查过程中的沟通 Tips 65

4.1 与研究中心人员的沟通 65

4.2 与 CRC 的沟通 68

5. 监查报告的完成与提交 69

6. 问题的跟进与管理 71

缩略语

缩略语	扩展术语	缩略语	扩展术语
ADA	抗药抗体	PFS	无进展生存期
PD	疾病进展	ORR	客观缓解率
ADC	抗体偶联药物	OS	总生存期
DOR	缓解持续时间	EC	伦理委员会
PR	部分缓解	SD	疾病稳定
AE	不良事件	ECOG PS	（美国）东部合作肿瘤小组体能状态评分
AESI	特殊关注的不良事件	eCRF	电子病例报告表
AJCC	美国癌症联合委员会	ECG	心电图
ALP	碱性磷酸酶	EGFR	表皮生长因子受体
ALT	丙氨酸氨基转移酶	EOI	输注结束
ANC	中性粒细胞计数	EOT	治疗结束
APTT	部分凝血活酶时间	FAS	全分析集
ASCO-CAP	美国临床肿瘤学会-美国病理学家学会	FDA	（美国）食品药品监督管理局
AST	天门冬氨酸氨基转移酶	GCP	临床试验管理规范
AUC	药时曲线下面积	HCT	红细胞压积
BI	输注前	Hb	血红蛋白
BIRC	盲态独立评审委员会	HBV	乙型肝炎病毒
BMI	体重指数	HBcAb	乙型肝炎核心抗体
CAR-T	嵌合抗原受体 T 细胞	HBsAg	乙型肝炎表面抗原
CDK	细胞周期蛋白依赖性激酶	HCG	人绒毛膜促性腺激素
TRAE	治疗相关不良事件	HCV	丙型肝炎病毒
CL	清除率	RECIST	实体瘤的疗效评价标准
CI	置信区间	RNA	核糖核酸

CRF	病例报告表	RP2D	2 期临床试验推荐剂量
CR	完全缓解	SAE	严重不良事件
CRO	合同研究组织	SBP	收缩压
CT	计算机断层扫描	HIV	人类免疫缺陷病毒
CTCAE	不良事件通用术语标准	HR	激素受体
DAR	药物抗体偶联比	TNBC	三阴性乳腺癌
DBIL	直接胆红素	ICF	知情同意书
DBP	舒张压	Ig	免疫球蛋白
DCR	疾病控制率	ILD	间质性肺疾病
DLT	剂量限制毒性	INR	国际标准化比值
DNA	脱氧核糖核酸	ULN	正常值上限
MTD	最大耐受剂量	IRR	输液反应
NCI	（美国）国家癌症研究所	irAE	免疫相关不良事件
NEUT	中性粒细胞	SOA	研究活动计划表
LDH	乳酸脱氢酶	SOP	标准操作规程
mAb	单克隆抗体	SpO2	外周血氧饱和度
MRI	核磁共振成像	SUSAR	可疑且非预期严重不良反应
PT	凝血酶原时间	PLT	血小板
Q3W	每 3 周一次	PK	药代动力学
QD	每日一次	SS	安全性数据集
QTc	校正的 QT 间期	t1/2	半衰期
RBC	红细胞计数	TBIL	总胆红素
NSCLC	非小细胞肺癌	TEAE	治疗期间出现的不良事件
NYHA	美国纽约心脏病协会	WBC	白细胞计数

PD-L1	程序性死亡配体 1	WHO Drug	世界卫生组织药物词典

1. 研究中心的筛选

a. PSV 访前准备

步骤	任务	具体内容
步骤 1	确认是否 PSV 豁免及条件评估	1) 根据 SOP-CO-2004 Pre-Study Visit 在过去的十二个月内，主要研究者在同一治疗领域且设备保持不变的情况下进行主要研究者/中心曾经与宜联生物的合作方合作过，且至今仍被视为合适和合格的主要研究者/中心核实豁免标准并通过邮件进行豁免。 2) 若符合豁免：CRA 整理豁免理由，提交 PM 审批；留存豁免审批邮件归档 TMF，无需开展 PSV 现场/远程访视，直接进入后续 SSU 流程。 3) 不满足豁免条件：正式启动 PSV 流程。
步骤 2	PSV 前期合规与资料预审	1) CRA 完成本项目 SOP、方案培训，培训记录可追溯。

		2) 完成研究者黑名单核，PI 完成备案；若存在黑名单风险，立即上报 PM，该中心直接排除。 3) 审阅可行性调研问卷反馈，收集 PI 简历、财务披露表等预资料；梳理中心初步风险点，形成现场待核实问题清单。 4) 多合作方项目，与 CRO/第三方对齐 PSV 执行标准、需要收集的文档清单。
步骤 3	PSV 访视申请与审批	1) CRA 填写《PSV 访视审批表》，写明：中心编号、中心名称、PI、访视形式（现场/远程）、计划访视日期。 2) 将审批表提交 PM 进行审批；PM 审批通过后方可预约中心开展 PSV；PM 驳回则根据意见调整或直接淘汰该中心。
步骤 4	访视预约，发送 PSV 确认信	1) 联系 PI、机构对接人协调访视时间；确保 PI、药房/IP 管理人员、样本处理负责人能够参与访

		视。 2) 编辑 PSV 确认信，写明：访视时间、议程、待核查设施、参会人员、现场待收集文件清单。 3) 邮件发送 PSV 确认信给到 PI 及中心联系人，抄送 PM 及项目组；邮件副本留存用于 TMF 归档。 4) 远程 PSV：提前确认视频会议工具，确认中心网络条件。
步骤 5	PSV 工具材料准备	准备全套访视工具： 1) PSV 演示 PPT、方案摘要； 2) 访视签到表； 3) 调研问卷； 4) 保密协议； 5) 待收集文件清单； 6) 现场行动项记录模板； 7) 提前梳理项目 Q&A。

b. PSV 现场/远程访视执行

步骤 1	签到确认参会人员	收集访视签到表，记录到场人员岗位；若 PI 或关键岗位人员缺席，评估

		是否继续访视，必要时重新约期。
步骤 2	研究团队资质评估访谈	逐项访谈评估，书面记录评估结果： 1）PI 及团队本治疗领域临床经验、既往临床试验执行经历； 2）GCP 及国内法规培训有效性； 3）研究者财务利益冲突情况； 4）当前在研项目，评估受试者招募资源冲突； 5）团队可投入本项目人力、时间；PI 对附属分站点监督管理能力； 6）IP 管理、样本采集转运岗位人员资质； 7）机构既往核查历史、缺陷整改情况（如有）； 8）团队对 GCP、试验方案、监管义务的理解。
步骤 3	中心设施设备巡视评估	1） 现场实地巡场（远程 PSV 通过视频完成）： 2） 方案需要的检查、检验操作场地； 3） 试验设备状态、维护记录、有效

		校准证书； 4) 实验室资质及有效期； 5) 样本采集、储存、冷链转运条件，温控冰箱运行状态； 6) 急救设备、应急处置流程； 7) 病历、试验记录安全存储区域，受试者隐私保护条件； 8) 试验用药品储存区域、温区、持续温度监控记录； 9) EDC 系统网络软硬件、信息安全； 10) 可供监查开展的办公及网络环境。
步骤 4	项目方案与监管责任研讨	与 PI 及核心团队沟通项目全部关键内容并做好记录： 试验目的、方案摘要、研究者手册； 试验操作流程；IP 管理全流程要求； 入排标准、受试者招募预期；禁止合并用药；知情同意流程；方案违背识别上报；SAE 安全性上报流程； EMR/EDC 系统要求；PI 法定职责；

		伦理递交时限；人类遗传资源相关；监查工作预期。
步骤 5	源数据核查权限确认	1）纸质病历中心：确认源文件管理规则、认证副本制作核验流程。 2）EMR 电子病历中心：确认 CRA 源数据只读访问权限；无法直接访问的确认陪同核查或认证副本流程。源数据访问存在重大障碍，必须立即上报 PM，评估是否淘汰该中心。
步骤 6	ISF 研究者文件夹现状评估	评估中心 ISF 文件夹建立、维护机制；审阅现有监管文件；识别文件缺失、版本错误等缺陷，现场告知中心需要补齐的材料。
步骤 7	汇总现场发现，整理行动项，访视收尾	1） 区分缺陷项、观察项；每条行动项写明问题描述、责任方、整改内容、建议完成时限。 2） 2.识别的重大风险第一时间升级上报 PM。

c. PSV 访后闭环工作

步骤 1	重大风险上报	访视识别重大风险、致命缺陷，邮件上报 PM，评估中心是否保留候选资格。
步骤 2	跟进中心补充资料、推动行动项整改	发送 PSV 跟进信给到研究中心，列明待补齐文件、整改事项、时间节点；邮件抄送项目组；持续跟踪中心提交整改材料，逐条闭环行动项；逾期未完成及时向 PM 同步风险。
步骤 3	撰写 PSV 正式报告	报告包含内容：访视基础信息；研究团队评估；设施设备评估；受试者资源评估；全部发现项（缺陷/观察项）；完整行动项清单； CRA 专业推荐意见（推荐接纳/条件接纳/不推荐接纳该中心）。 a) 如果一次 PSV 覆盖多家中心，需要对每家中心独立评估描述。 b) 初稿提交 PM 审核；接收 PM 反馈修订，输出 PSV 终版报告。

步骤 4	文件初审与 TMF 归档	对 PSV 全套资料做质量初审：签名、日期、版本、脱敏、命名规范检查。 ✓ 需要归档文件：调研问卷、保密协议、PSV 审批表、PSV 确认信及邮件、访视签到表、PSV 跟进信、PSV 终版报告、豁免邮件（适用）、黑名单核查记录、闭环证据，按 TMF-index 上传 eTMF。 ✓ 调研问卷和保密协议邮寄 CTA，跟进保密协议的签署完成。 ✓ 更新 SSU 中心启动跟踪台账，记录 PSV 结果、行动项状态。
步骤 5	接收 PM 最终中心准入决策，通知中心	PM 审阅 PSV 报告、全部行动项，做出最终决策：纳入候选/条件纳入/淘汰中心。 CRA 向中心发送《中心筛选感谢函》，同步筛选结果；通知邮件归档 TMF。

二、中心 SSU

阶段 1：PSV 完成，确认中心纳入项目候选

- CRA 完成 PSV（中心筛选访视），输出 PSV 报告，给出中心是否推荐纳入项目的评估意见。
- PM 审批 PSV 报告，正式确认该中心纳入项目候选；若 PM 否决，该中心 SSU 流程终止。
- CRA 核对 PSV 所有行动项：高、中风险问题必须闭环；低风险项明确后续管控措施。
- 确认 CDA 保密协议已签署生效。
- 填写该中心 SSU 跟踪台账，记录立项、伦理、合同、人遗、物资、系统各节点状态，持续更新。

阶段 2：机构立项，研究者监管文件收集

1. 向机构办获取该机构立项要求：材料清单、装订要求、线上/线下递交、盖章要求、机构内部审批周期。
2. 整理机构立项全套申报资料，包含：
    - 方案/IB
    - 申办方资质、CRO 资质（如有）；
    - 知情/招募广告（通用版和专用版按照中心要求）；
    - PI 简历、GCP 证书、执业资质、财务披露表；
    - 项目批件/临床试验通知书；
    - 中心实验室资质、SMO 资质、CRO 资质等

- 团队成员分工表及 PI/研究者资质文件
- PI 及参与研究人员简历、GCP 培训证书、执业证书、财务披露表；实验室资质、正常值范围、设备校准证书等。
- 其他机构要求其它表单。

3. 递交机构立项申请；跟进机构形式审查进度；接收机构反馈意见，及时修改补材料。

4. 收到机构立项通过回执；更新 SSU 台账。

阶段 3：伦理委员会申报，获取正式伦理批件

✧ 收集伦理申报全套材料，核对版本一致性（方案、ICF、招募广告必须为最终获批版本）。

✧ 核对伦理会排期、递交截止时间；确认伦理审查方式（会议审查/快速审查）。

✧ 按伦理要求递交全套送审资料；同步跟进伦理费付款（CTA 执行付款流程）。同时需要回收中心开具的伦理费发票。

✧ 接收伦理委员会意见；区分格式问题、医学问题；格式问题 CRA 直接修改，医学问题提交医学团队协助答复；完成答复重新递交。

✧ 获取正式伦理批件；核对批件信息：项目名称、版本号、PI、审查意见完整，签字盖章齐全；核对 ICF 批准版本。

✧ 伦理批件、批准版 ICF 原件扫描留存；更新 SSU 台账。

阶段 4：合同谈判签署+人类遗传资源分中心备案

4.1 临床试验协议签署

❋ CRA 收集中心的检查费明细及 中心的合同条款及收费标准，根据项目组合同框架，撰写合同，整理发送 PM/财务/法务进行审核。

- CRA 按照意见修改，内部完成合同版本修订，发送 PI/科室/机构进行审核。如是 SMO 的三方协议，还需要 SMO 公司进行审核。
- 审核后 CRA 汇总多方意见，CRA 进行沟通协调修改定稿。（主协议/CRC 协议/伦理审核协议等）
- 合同定稿后 CRA 发起盖章申请，备注清楚盖章要求、寄送、份数，PM 审批后 CTA 负责打印、盖章、寄送。
- 中心机构完成盖章后，将签署完成的生效合同按照要求回收甲乙丙方。
- CRA 确认合同已经完整签署生效；更新 SSU 台账。
- CRA 在启动前，按照协议的要求申请进行首付款付款，并跟进首付款的发票回收。

4.2 人类遗传资源分中心医疗机构备案（国内有样本项目强制）

1) CRA 按照要求准备中心的遗传办资料：遗传办申请表（如有）、分中心承诺书、本中心伦理批件。
2) 提交机构，机构审核通过发起盖章及法人签字，拿到分中心承诺书盖章件。
3) 提交 CTA/遗传办专员，完成人遗平台分中心备案递交。
4) CRA 核对系统状态为“接收/已备案”；拿到分中心备案完成截图。
5) 更新 SSU 跟踪台账。

2、中心启动访视流程

a. SIV 访前准备

步骤 1	SIV 前置启动条件核查	1）机构立项完成。 1) 伦理：获取正式伦理委员会批件，版本为当前生效版本；知情同意书为伦理已批准版本 2) 合同：研究中心协议、相关附属协议完成双方签署盖章生效。 3) 人遗：人遗分中心医疗机构备案完成，取得备案接收状态。 4) PSV 遗留问题：PSV 产生全部高/中风险行动项已闭环；低风险项明确后续管控方案。 5) 物资条件申请： a) IP 试验用药品已送达中心；冷链储存设备（冰箱、温监系统）到货、校准证书有效； b) 试验所需设备、耗材、试剂盒送达，设备校准在有效期； c) 样本采集、转运相关条件就绪。 d) 知情、招募广告、条幅（如适用）、

		入排卡、手册、问卷等 e) 输液泵、药品转运箱、药品转运温度计等 6) 系统条件：EDC/eCRF、IRT 随机系统账号已创建、权限分配完成，可以正常登录使用。 7) 经费里程碑：按项目要求确认合同约定付款节点满足条件。
步骤 2	提交 SIV 访视申请，获取审批	CRA 填写《研究中心启动访视审批表》，写明：中心编号、中心名称、PI、访视形式（现场/远程）、计划访视日期、参训人员清单、前置条件核对情况。 1. 将审批表提交 PM 审批。 2. PM 审核通过后方可安排访视；若 PM 驳回，CRA 根据意见补齐条件后重新提交。
步骤 3	访视预约，发送 SIV 确认信	和 PI、研究机构协调访视时间，确认 PI、主要研究医生、CRC、药房/IP 管理人员、样本处理人员必须到场参加培训。 1. 制作 SIV 访视确认信，内容包含：访视时间、会议议程、参会人员要求、

		中心需要提前准备的资料清单、现场待收集文件清单。 2. 邮件发送 SIV 确认信至 PI、中心对接人，抄送 PM、项目组；邮件副本留存用于后续 TMF 归档。 3. 提前协调会议软件，发送会议链接，医学/PM/CRC/协调/市场部门人员。
步骤 4	研究者文件夹 ISF 交付文件整理，核对版本、签字页完整性	1) 研究者手册 IB（含 PI 签字页） 2) 研究方案（含 PI 签字页） 3) CRF/eCRF 表格及填写指南 4) 伦理批准版本知情同意书（样本版+空白版） 5) 招募广告/受试者宣传材料（伦理批准版） 6) IP 药检报告/试验用药品说明书 7) 临床试验协议 8) 伦理批件全套文件 9) 实验室相关文件：实验室资质、正常值范围 10) 《授权分工表》、《原始数据确认表》 a) 11.保险证明/保单

		b) 12.国内项目：人类遗传资源相关配套文件
步骤 5	SIV 培训及现场工具准备	制作/更新 SIV 培训 PPT，覆盖全部培训要点；梳理项目 Q&A，提前准备高频问题应答。 1) 准备工具表单：SIV 培训签到表、现场行动项记录模板、待收集文件清单。 2) 核对前期 PSV 遗留问题清单，准备现场跟进要点。 3) 提前确认启动会会场设备及会场布置，会议资料准备。
步骤 6	物资、系统二次确认	确认 IP、冷链温控设备到位，校准证书有效；确认温控监控功能正常。 1) 确认 EDC、IRT 账号激活，权限配置无误。 2) 确认样本采集、储存设备、校准状态。 3) 内部同步 PM、CTA，确认合同、物资、人遗无新的风险。

b. SIV 现场访视执行

步骤 1	签到，确认参训人员	收集 SIV 培训签到表，记录到场人员姓名、岗位、GCP 培训情况。 1. 确认关键岗位（PI、IP 管理员、样本处理人员）参会；如关键人员缺席，评估是否继续 SIV；必要时暂停访视，重新安排时间。 2. 签署启动会签到表和本项目的培训记录表。
步骤 2	项目全套启动培训	试验概况：试验背景、研究目的、方案设计、观察指标； 1. 受试者管理：入排标准、筛选流程、随访流程；受试者招募；随机化操作（如有）； 2. 知情同意：知情同意流程、版本管理、重新知情条件； 3. 合并用药：允许/禁止使用药物； 4. 安全性管理：AE/SAE 识别、记录、上报时限；SUSAR 接收与处理；紧急破盲流程；受试者提前终止流程； 5. 研究者职责：ICH-GCP、国内 GCP

		法规下研究者责任；源数据、源文档管理要求；原始数据确认表要求； 6. 试验用药品 IP 管理：接收、储存、温湿度监控、清点、发放、回收、销毁流程；IP 异常（超温、破损）处置流程； 7. 生物样本管理：样本采集、编号、保存、冷链转运、销毁流程； 8. EDC/eCRF 填写要求：录入、修改、质疑答复；IRT 系统操作（如适用）； 9. 方案违背识别、记录、上报流程； 10. ISF 研究者文件夹建立、更新、保存管理要求； 11. 国内项目专项：人类遗传资源相关义务、样本信息管理要求。 12. 培训结束收集现场提问，全部问题予以答复并记录。
步骤 3	核查研究者文件夹（ISF）现状	检查中心 ISF 文件夹架构是否符合 TMF index 要求。 1. 逐项核对已有文件：版本、签字、日期完整性；识别缺失文件、旧版文

		件、签名不全等缺陷。 2. 明确告知中心需要补充、替换的文件清单。
步骤 4	现场收集中心监管文件	伦理委员会全套批件、伦理递交相关文件； 1. PI 的方案、IB 签字页； 2. 《分工授权表》;《原始数据确认表》; 3. PI 及参与研究人员简历、GCP 证书、执业资质证明； 4. 实验室资质证书、实验室正常值范围； 5. 试验相关设备校准证书； 6. 药检报告接收回执； 7. 其他项目特定文件，如药物、生物样本、肿评表等相关的表格。 8. CRA 现场收集或确认后续提交的监管文件，核对每份文件签字、日期、版本有效性：文件存在缺陷的，标记在行动项，要求中心限期重新提供。
步骤 5	设施、物资、系统复核确认	复核 IP 储存区域、冷链设备运行、温度监控记录； 1. 复核样本处理、储存场地条件；

		2. 确认 EDC/IRT 账号可以正常登录； 3. 复核 PSV 遗留行动项整改落实情况。
步骤 6	整理现场行动项，访视收尾	汇总本次访视全部发现，区分：缺陷项、观察项；每条行动项写明：问题描述、责任方、需要完成的内容、建议完成时限。 1. 重大风险第一时间升级 PM。 2. 确认中心人员理解全部待办要求。

c. SIV 访后闭环工作

步骤 1	重大风险上报	CRA 如访视识别重大缺陷，立即邮件向 PM 上报风险，评估是否允许中心后续入组。
步骤 2	发送 SIV 访视跟进信	CRA 依据现场行动项清单，撰写 SIV 跟进信，明确告知中心需要补齐的文件、整改内容、完成时限；邮件发送 PI 和中心联系人，抄送项目组；邮件留存归档
步骤 3	跟进行动项闭环	CRA 持续跟进中心提交补充文件、完成整改；收到材料后核对文件质量；逐条关闭行动项；未按时限完成的，持续提醒并向 PM 同步风险。
步骤 4	撰写 SIV 访视报告	报告内容：访视基本信息；培训实施情况；ISF 文件夹核查；监管文件收集情况；设施设备与系统核查；全部发现项（缺陷/观察

		项)；完整行动项清单； 1. 初稿完成提交 PM 审核；接收 PM 反馈意见，修订形成 SIV 终稿报告。
步骤 5	文件初审与 TMF 归档	对 SIV 全套资料做质量初审：检查签名、日期、版本、脱敏、命名规范。 1. 将以下文件按 TMFindex 要求上传至 eTMF 归档： • SIV 访视审批表 • SIV 访视确认信及邮件 • SIV 培训签到表 • SIV 跟进信及往来邮件 • SIV 访视终版报告 • 本次收集全部中心监管文件 2. 更新监查跟踪台账，记录 SIV 完成状态、行动项状态。
步骤 6	等待 PM 中心入组放行决策	CRA 仅输出评估和推荐意见；**由 PM 综合 SIV 报告、行动项闭环情况，正式审批中心是否允许开展受试者筛选入组；未获得 PM 放行，中心禁止入组。**

阶段四：SIV 完成后持续跟踪

1. CRA 将 SIV 行动项纳入后续监查访视必查内容；

2. 发送启动访视跟进函。
3. CRA 与研究团队保持积极的沟通，跟进启动访视中提出的疑问或出现的问题: 《研究中心沟通报告》或其他类似报告来记录沟通内容。

3. 临床试验监查（临床试验质量管理）

3.1 知情同意监查要点

ICH-GCP 和中国的法规规定在药物临床试验的过程中，必须对试验参与者的个人权益给予充分的保障。试验参与者的权益、安全和健康高于对科学和社会利益的考虑。同试验参与者签署知情同意书是保障试验参与者权益的主要措施。

任何一项临床研究，只有当受试者签署了知情同意书后方可让试验参与者进入临床研究。在签署知情同意书后，必须给试验参与者一份知情同意书的复印件或签署两份，一份存档，一份交给受试者。

在临床研究中签署知情同意书应注意以下几点：

1. 研究者和试验参与者应在知情同意同时签署各自的姓名和日期

在实际过程中，容易出现的问题有：

1） 试验参与者仅仅签署姓名，未注明签署日期

2） 试验参与者没有得到签署完成的知情同意书副本

3） 试验参与者的法定代表人仅签署了试验参与者姓名，而没有签本人姓名并注明和试验参与者关系

4） 更新的知情同意书获批后，未及时给受试者重新知情

5） 知情同意书中没有记录研究者或者伦理委员会的联系方式

6） 知情同意过程记录不完整

7） 知情同意书签署版本错误

知情同意过程中，研究者应让试验参与者充分阅读，并给予充分的解

释，回答并记录试验参与者所有的提问，让试验参与者充分考虑后再签署 ICF

另外需要注意，只有有医疗资格的授权的研究者，才能同试验参与者亲属知情同意书

2. 所有与研究有关的临床检查和检测必须在签署 ICF 后才能进行

研究者需要区分什么是临床常规操作，什么是与研究有关的操作。临床常规操作是以临床诊治为目标，无论试验参与者参加研究与否都必须进行。而与研究有关的操作则是指该项研究中所要求的检查，不是以诊治为目的，所以必须要在签署知情后才能进行。

3. 其他知情同意应避免的错误

下列错误必须避免：1） 研究者代签日期 2）他人代签知情同意书

知情同意书常见问题：

Q1：研究者使用了旧版本知情同意书对试验参与者进行知情

- ✧ 交叉核对近期所有试验参与者的 ICF 是否签署正确版本，评估对于试验参与者的安全和权益造成的影响，第一时间上报项目组，PI 及伦理委员会并记录于监查报告
- ✧ 再次和研究者及 CRC 强调新版知情同意书已经获批，告知 ICF 更新内容，完成培训表
- ✧ 销毁旧版本空白 ICF，确认新版本 ICF 已经送达研究中心
- ✧ 要求研究者尽快联系试验参与者进行新版 ICF 知情并完成签署，将过程记录于病历中。

- ✧ 如果试验参与者此前已经完成随访，且随访间隔较长，建议研究者电话知情，将实际情况记录在病历中，待试验参与者下次随访时及时补充签字，签署日期

Q2：新版 ICF 获批后，研究者未在最近一次访视给试验参与者进行知情

1） 交叉核对近期所有试验参与者是否在最近一次访视都签署了新版的 ICF

2）评估新版 ICF 晚签对于试验参与者的安全和权益造成的影响，第一时间上报项目组、PI 及伦理委员会，并记录于监查报告

3）再次和研究者强调新版 ICF 的获批时间，提醒后续受试者访视应该及时签署新版 ICF，完成培训表

4）要求研究者尽快联系试验参与者进行新版 ICF 知情并完成签署，将过程记录于病历中。

Q3：在中心发现了同一位试验参与者的 2 份原件

- 第一时间让研究者与试验参与者确认是否已经获得 ICF 副本，交叉核对其他试验参与者是否有收到一份 ICF 原件或副本
- 考虑到试验参与者可能会因未被提供 ICF，没有办法仔细阅读以及和家人商量，导致试验参与者的意愿收到影响。不恰当的知情同意过程应当汇报给伦理委员会，CRA 将所有的发现记录于监查报告。
- 在试验参与者下一次访视时提供其中一份 ICF 原件，如果试验参与者以及出组，将其中一份 ICF 原件寄给试验参与者。将以上过程记录于研究病历。

- 再次对研究者进行知情同意过程的相关培训，完成培训记录

Q4: 在公正见证人处发现是本项目其他受试者的签名

- ✓ 确认这次的知情过程是否正确，记录是否完整
- ✓ 研究者对公正见证人的理解是否正确，再次对研究者进行知情同意过程的相关培训，完成培训记录
- ✓ 交叉核对其他试验参与者的 ICF 是否有公正见证人，是否适合研究无关的人员，包括试验参与者，被授权的研究人员等
- ✓ 考虑到该公正见证人可能会影响到试验参与者参加研究的意愿，不恰当的知情同意过程应当汇报给伦理委员会，并且对试验参与者进行重新知情，获取新的签署知情同意书，必要时确定合适的公正见证人。

Q5: 如果更换 PI 或伦理委员会地址有变更是否需要更新中心 ICF

如果已获伦理批准的中心 ICF 中写明了 PI 的姓名，伦理委员会地址等，这些信息发生变更时，中心 ICF 需要更新并获得伦理批准

Q6: 试验参与者补助没有依照 ICF 里描述的频率进行发放

- ❋ 建议 ICF 里的描述要与实际一致，ICF 里描述的频率最好时一个范围，比如 3-6 个月，避免实际发放时发生了一些延误导致 Non Compliance
- ❋ 尽量按照 ICF 里描述的频率进行发放，如果实际做不到，请更新 ICF 或以其他书面文件澄清，更新后需获得伦理批准和试验参与者的同意。
- ❋ 如 CRA 在监查过程中发现发放不一致，需要将发现的问题记录在监查报告中

3.2 方案依从性的监查要点

方案偏离（Protocol Deviation, PD）：

指在临床试验中，任何有意或无意偏离和不遵循经伦理委员会批准的试验方案规定的治疗规程、检查或数据收集程序的行为。方案偏离按严重程度可分为严重偏离（major

protocol deviation）和轻度偏离（minor protocol deviation）

严重偏离：指严重影响受试者权益、安全或者临床试验数据的有效性；

轻度偏离：严重程度未达到严重偏离。但如果同类轻度方案偏离反复出现则可能被归为严重方案偏离方案偏离（Protocol Deviation, PD）：指在临床试验中，任何有意或无意偏离和不遵循经伦理委员会批准的试验方案规定的治疗规程、检查或数据收集程序的行为。方案偏离按严重程度可分为严重偏离（majorprotocol deviation）和轻度偏离（minor protocol deviation）

常见 PD 可归类为 7 项：

1）不符合入选和排除标准

2）知情同意签署不规范

3）医学观察/评价记录不全

4）药物管理存在疏漏

5）不良事件及合并用药不当

6）检查漏项/超窗

7）其他

8） 除此之外，若发生严重影响到试验参与者安全或严重违反 GCP 相关法律法规等情况，伦理委员会还可能做出限制研究者在该试验中的授权范围、指派高年资研究者指导、限制或禁止研究者或申办方新申报研究项目等决定。

PD 管理流程（SOP-CO-2017 The Recording and Handing of Protocol Deviation）

PD 记录通常包括以下几个部分：

1）试验参与者筛选号/随机号

2）药物批号/编号

3）访视周期/访视日期

4）PD 的描述/原因/偏离分类/严重程度

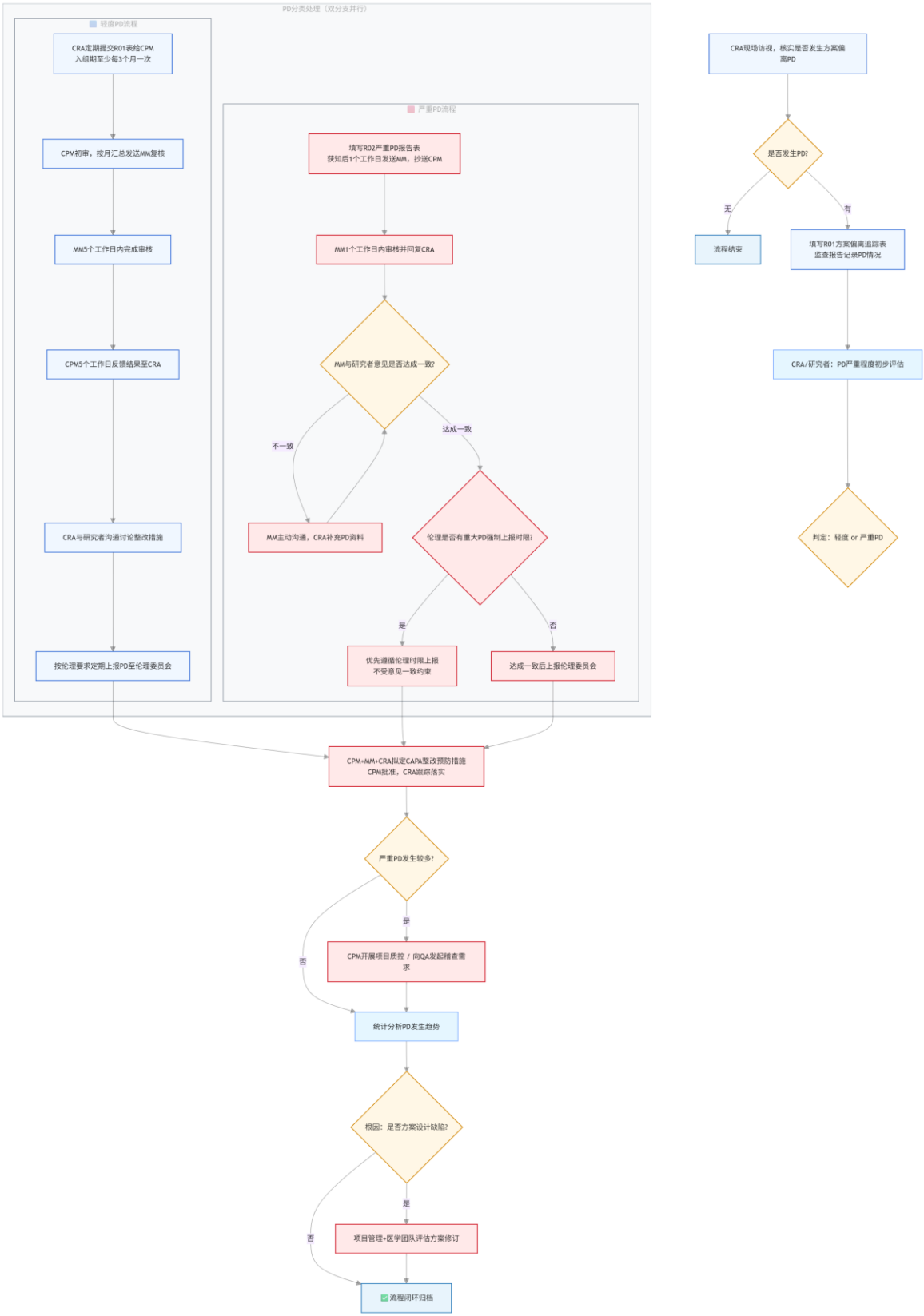
5）PD 的发现日期

6）纠正/预防措施（针对 PD 采取的措施）

7）是否上报伦理

8）研究者及伦理签字/日期等

9）其他


PD分类处理（双分支并行）
轻度PD流程
CRA定期提交R01表给CPM
入组期至少每3个月一次
CPM初审，按月汇总发送MM复核
MM5个工作日内完成审核
CPM5个工作日反馈结果至CRA
CRA与研究者沟通讨论整改措施
按伦理要求定期上报PD至伦理委员会
严重PD流程
填写R02严重PD报告表
获知后1个工作日发送MM，抄送CPM
MM1个工作日内审核并回复CRA
MM与研究者意见是否达成一致?
不一致
达成一致
MM主动沟通，CRA补充PD资料
伦理是否有重大PD强制上报时限?
是
否
优先遵循伦理时限上报
不受意见一致约束
达成一致后上报伦理委员会
CPM+MM+CRA拟定CAPA整改预防措施
CPM批准，CRA跟踪落实
严重PD发生较多?
是
否
CPM开展项目质控 / 向QA发起稽查需求
统计分析PD发生趋势
根因：是否方案设计缺陷?
是
否
项目管理+医学团队评估方案修订
流程闭环归档
CRA现场访视，核实是否发生方案偏离PD
是否发生PD?
无
有
流程结束
填写R01方案偏离追踪表
监查报告记录PD情况
CRA/研究者：PD严重程度初步评估
判定：轻度 or 严重PD

常见 CAPA 措施

在采取 CAPA 措施之前，一定要分析 PD 发生的根本原因（Root Cause）

在分析完原因后常见的 CAPA 措施有：

- CRA 及时将 PD 记录在监查报告中并上报项目组
- 研究者及时上报伦理
- 如因研究者操作层面导致的 PD，应及时加强研究者培训
- 如因受试者的依从性导致的 PD，应建议研究者加强试验参与者教育，并将患教过程记录在病历中
- 如因方案涉及或者 SOP 的规定不合理而导致的 PD，需要及时和项目组沟通。建议增加补充说明或进行必要的方案修正。

① FAQ1. 研究者漏报 PD 或报告不及时

因为 GCP 或相关的法规、SOP 对不依从/违背或偏离方案的报告时限未曾明确具体的报告时限，仅要求“及时”报告，有较多的研究者报告不及时或漏报，甚至有些研究者在递交结题审查时才对临床研究过程中发生的不依从/违背方案事件进行整理报告。针对 PD 漏报或报告不及时，我们给出以下建议：

- 如果发现漏报或者晚报的 PD 需要及时进行上报，并且在报告中阐述 PD 漏报或晚报原因。但是有可能会发生伦理不接受晚交文件或者对阐述的晚交理由不接受的情况。此时需要和伦理进行沟通解释，并且在报告中阐述详细的 CAPA 措施，并确保后续能够及时进行 PD 递交。
- 针对晚交或者漏报的情况一定要进行 Root Cause 分析，避免再次发生

② FAQ2. 同类型的违背/偏离方案事件重复发生

除了常见的 PD 漏报或者晚报的情况，还存在同样的偏离事件重复发生的现象，如遗漏某项检测项目、受试者访视超窗、漏服或多服试验药物等。针对这种情况我们给出以下建议：

CRA 协助研究者对事件重复发生进行 Root Cause 分析，提供可操作的建议，如非人为因素导致的事件可能涉及修改方案和研究流程，如是人为因素导致的则需要加强培训。PD 报告中页应写明此类事件属第几次发生，重复发生的根本原因。

3.3 原始数据核查

3.3.1 核查方式与判定标准

核查方式（SDV/SDR）：对 eCRF 数据 100%核查并与源文件比对。按中心对电子病历的开放程度，采用三种方式之一：

1. 向 CRA 提供电子病历只读访问权限的，直接在线审查；
2. 提供完整电子病历认证复印件的，审查复印件；
3. 两者均不提供的，与研究中心人员实时审查，将打印记录与电子记录比对抽查，确认打印原始文件的准确性与完整性。

核心判定标准（六性）：

- 真实性：源文件真实产生，无伪造、复制、倒签、事后补写；
- 完整性：方案要求的全部信息均有原始记录，无关键缺失；
- 一致性：源文件 ↔ eCRF ↔ 统计数据库三者完全匹配；
- 可溯源性：CRF 每个数据点均有对应原始纸质/电子源文件支撑；
- 及时性：操作完成后同步记录，禁止批量事后补录；
- 可复现性：原始记录永久留存，修改痕迹全程可追溯（纸质单线划改+签名日期；电子核查 Audit Trail、权限与备份）。

3.3.2 风险导向核查优先级（ICH E6 R3）

1、100%必查高风险数据：入排标准、知情同意、SAE、主要疗效终点、给药剂量、死亡/严重脱落病例；

2、抽样核查：次要疗效指标、常规合并用药、轻度 AE、常规生命体征（按申办方风险监查计划抽样）。

3.3.3 核查要点

（一）受试者资格与知情同意

- 资格：原始病历中入排标准全部指标（年龄、病史、既往治疗、基线实验室/影像/诊断依据）完全符合方案；筛选检查报告单的时间、数值、结论与 CRF 一致，无补报、替换报告；筛选失败者完整记录失败原因；核对身份证等身份凭证，确认受试者真实存在。
- 知情同意：ICF 签署日期早于任何试验操作，受试者/监护人及研究者签名齐全；使用伦理批准的最新版本；方案变更、新增风险时补充/重新知情并完整留档；文盲见证知情、儿童监护人知情记录完整可查。

（二） 数据隐私

将严格遵循相关法律法规及方案要求，保护受试者隐私。所有收集的受试者数据将进行去 标识化处理，仅以受试者编号标识。研究文件、数据库及传输过程均采取安全措施，防止未经 授权的访问、使用或泄露。查阅源数据仅限于监查、稽查、伦理审查和监管检查等授权目的。

（三）访视与方案依从性

- 每次访视的病历记录（日期、生命体征、症状问诊）与 CRF 时间、数值完全匹配；
- 缺失访视、失访、提前退出须记录原因，CRF 如实同步，无隐瞒脱落病例；

- 方案规定的检查项目（实验室、影像、内镜、量表）原始报告齐全，时间窗合规，漏做/推迟均记录在源文件与 CRF；
- 量表、问卷以受试者手写原件为准，与 CRF 一致，禁止事后篡改。

（四）eCRF 与源数据一致性

- 对源数据 100%核查；HIS 病历创建、保存、锁定时间逻辑合理，修改留痕；
- 核查 LIS、影像、ECG、超声等系统溯源，以及 HIS 中的合并用药与治疗记录；
- 入组前核查既往病史、既往肿瘤治疗史及首次给药前内其他治疗史（含处方药、非处方药、中草药、手术史），判断是否符合入排；
- 电子数据核查 Audit Trail（操作人、时间、修改前后值），确认仅授权人员可修改，数据备份可恢复。

（五）试验用药品（IP）

- 药房领用、分发、回收记录：药品编号、发放日期/剂量/频次、回收数量与 CRF 给药记录 100%匹配，并盘点实际库存与记录一致；
- 受试者日记卡（手写）记录每日服药时间、剂量、漏服，核算给药依从性（实际服药量/计划服药量），确认填写完整并签字；
- 剂量调整、停药须有原始医嘱并记录原因，CRF 同步变更过程；配制、注射过程符合方案/说明书，特殊情况完整记录；

- 储存温湿度原始记录、设备与温度计校准在效期内；运输申请单、运输单、温度记录完整归档（ISF），超温立即按流程上报。

（六）合并用药与合并疾病

- 门诊/住院处方、购药记录：试验期间全部合并用药（含中药、保健品）的名称、剂量、起止时间与 CRF 一致；
- 并发/基础疾病同步记录，无遗漏影响安全性或疗效的合并疾病；
- 确认未用方案禁用药物，使用者须完整记录原因。

（七）受试者日志卡

- 确认受试者是否按要求填写了整个记录周期
- 检查每一天的服药记录是否有遗漏，包括早、晚两次服药。
- 检查受试者签字是否完整。
- 基于日志卡和药物清点，初步计算受试者该周期的服药依从性（实际服药量/计划服药量）。

（八）安全性数据（AE/SAE）

收集期：自签署 ICF 起至末次给药后 42 天（±7 天）或开始新的抗肿瘤治疗前（以先发生者为准）根据每个项目方案有不同规定。

- AE 原始记录：发生起止时间、症状、严重程度、相关性、处理措施、转归，与 CRF 无偏差；新 AE 及特殊备注均已录入 eCRF，未结束者在后续访视持续评估至消退/稳定，研究结束时充分随访；

- SAE：住院病历、抢救记录、死亡报告等支撑文件确认发生时间、严重程度、因果判断真实；使用项目组 SAE 报表模板，按法规/方案时限书面报告申办方、伦理（IEC）并留存上报与接收凭证；
- 实验室异常（有临床意义）须在源文件记录研究者判断、复查与干预，CRF 同步记为 AE；
- 药物过量、妊娠事件、SUSAR 按相应流程收集与递交。

（九）疗效评价数据

- 主要终点原始客观报告：CT/MRI 原始影像及阅片报告、生物标志物检测原始数据、生存记录，100%重点核查；
- 终点评估时间、评估人、结论在源文件、CRF、统计数据库三者一致，无修改影像、替换报告；主观量表以原始填写件为准。

（十）实验室样品与检测

- 标本采集、离心、冻存、转运记录完整，采集时间窗符合方案，超窗记方案偏离；离心记录起止时间、转速/离心力、温度，采集至离心及入冰箱时间符合手册规定；
- 冰箱温度在规定范围且每个工作日记录，温度计在校准效期内；转运快递单、温度记录原件存 ISF、复印件存 TMF；中心实验室签收确认数量、无超温破损；
- LIS 原始导出（接收时间、检测时间、原始数值、质控）与 CRF 一致；标本编号与受试者一一对应；异常值复查记录完整；

- 不符合要求时，对相关研究者再培训并留存记录。

（十一）必备文件

- 伦理批件、会议记录、修正案，研究者资质与培训记录，设备校准证书均在效期内并完整存档；
- 既往监查发现的数据疑问，在源文件中完成更正并留痕。

3.3.4 常见 FAQ：

一、试验参与者资格与知情同意

Q1：筛选检查报告时间早于签署知情同意书，可以接受吗？

A:一般不可。方案允许用于筛选的既往检查结果，须在方案规定的窗口和条件下使用；否则应在签署 ICF 后再进行检查，否则可能涉及未知情先检查的方案偏离。

Q2：筛选期实验室检查在院外机构做，能否作为入组依据？

A:可以，但须有原始报告单，报告机构资质、检测方法和单位可溯源，关键指标（如病理、分子检测）通常需中心实验室或认可机构确认，且符合方案要求。

Q3：受试者签字日期晚于首次给药日期，如何处理？

A:属于重大方案偏离/合规问题。知情同意必须在任何研究相关操作前完成，须记录偏离、评估对受试者权益的影响，报告伦理并按 CAPA 处理。

Q4：文盲受试者如何签署知情同意？

A:由见证人全程参与知情过程并签字，受试者按手印或签名，研究者签名，记录见证过程。

二、eCRF 与源数据一致性

Q5：eCRF 与源文件数据不一致，以哪个为准?

A: 以源文件为准更正 eCRF，禁止篡改源文件去"迁就"CRF；更正须留痕（query、稽查轨迹）。

Q6：HIS 里病史记录时间晚于入组时间，怎么判定?

A:区分"补记"与"真实发生时间"。病历创建时间逻辑应自洽（先筛选、再入组、再给药），事后补记需注明补记原因和实际发生时间，大量集中补记是核查重点风险信号。

Q7：CRC 可以代替研究者修改 eCRF 吗?

A:CRC 可协助录入事务性工作，但医学判断和数据确认必须由授权研究者完成；query 的最终医学答复须研究者签字确认。

三、访视与方案依从性

Q8：访视超窗但没影响受试者安全，要报伦理吗?

A:要区分偏离的严重程度。所有偏离均应记录和评估；可能显著影响受试者权益、安全或数据可靠性的，须按 GCP 第四十三条书面报告伦理。

Q9：受试者失访，病历中没有记录原因，怎么办?

A:属原始记录不完整。应尽量溯源（电话记录、随访信、家属沟通记录）补充

说明，并如实记录，不可隐瞒脱落。

四、试验用药品

Q10：药物发放量与回收量对不上，常见原因有哪些?

A:日记卡漏填、发放记录漏登、受试者自行停药未报告、回收未清点。应以药房台账、处方、日记卡多方交叉核对，差额须书面说明。

Q11：运输途中短暂超温，药物还能用吗?

A:立即隔离该批药物，按研究药物管理计划上报申办方，由申办方基于稳定性数据书面判定可用/销毁，不得由中心自行决定继续使用。

Q12：GCP 药房代为保管药物，取用记录要点是什么?

A:转运前后时间逻辑、温度记录（如适用）、双方签字、库存台账同步更新，确保账物一致。

五、安全性数据

Q13：实验室检查值超标但没症状，要报 AE 吗?

A:看研究者判断：有临床意义（CS）的异常值须记录为 AE 并随访；无临床意义（NCS）也应在病历中写明判断依据。

Q14：受试者在院外用自费药出现 SAE，研究者不知道，谁负责报告?

A:受试者应被充分告知安全性随访义务，试验期间任何 SAE（无论是否与研究药物相关）均须收集上报；CRA 监查时可通过问诊记录和合并用药溯源发现漏报，这是 SDV 的高风险核查点。

Q15：妊娠事件算 SAE 吗?

A:妊娠本身通常不作为 SAE 报告，但须按方案收集妊娠信息并随访结局；符合 SAE 标准的情况（如胎儿异常、流产）按 SAE 处理。

Q16：末次给药后 50 天出现不良事件，还收集吗?

A:超出安全性随访期（如方案规定 42±7 天）后，一般不再收集，除非方案另有规定或研究者认为与研究相关。

六、疗效与终点数据

Q17：影像评估报告日期与扫描日期哪个算评估日期?

A:以方案定义为准，通常在 CRF 中分别记录扫描日期和评估日期，两者均须与源文件一致。

Q18：研究者评片与中心阅片/BIRC 结果不一致，以哪个为准?

A:数据库记录以方案规定的评估路径为准（如以 BIRC 为终点则记录 BIRC 结果），但研究者的原始评估意见也须完整保留在源文件中。

七、实验室样品

Q19：标本离心晚于手册规定时限，怎么处理?

A:如实记录实际时间，评估对检测结果的潜在影响，记方案偏离；必要时联系中心实验室评估样本是否可用。

Q20：样本运输温度记录缺失怎么办?

A:视为温控证据缺失，按超温流程处理（隔离、上报、申办方判定），并在 ISF

中留档。

八、数据修改与系统

Q21：纸质记录写错了怎么改?

A:单线划改、保留原字迹、修改人签名+日期，必要时注明理由；禁止涂黑、覆盖、撕页。

Q22：可以临时把 eCRF 账号借给同事录数据吗?

A:绝对禁止。一人一号，权限与授权分工表一致，账号共享会导致稽查轨迹失真，属严重违规。

如果需要，我可以把这些 FAQ 整理成与手册风格一致的 Word 文档，或针对你们具体项目（如 ADC/细胞治疗）补充特有问题。

3.4 试验药物的监查要点

试验用药品 IP

• 核查药物库存是否充足；

• 核查研究药物的有效期、批号、药物编码等信息与供应单和检验报告是否一致；

• 核查药物发放记录回收表，试验参与者（发放、转运、使用、回收、销毁前后时间的逻辑关 系），确认试验参与者对药物发放与回收记录是否准确；

• 研究药物运输过中的申请单、运输单、出库单、温度记录已保存 ISF；

• 研究期间发生药物回收情况时，是否保存回收记录、运输单、温度记录（如适用）、接收 方签收回执已保存于 ISF 中；

• 如药物要求由 GCP 中心保存研究药物，使用前需提前至 GCP 中心领取时，中间的转运记 录和温度记录是否完整前后时间符合逻辑；

• 查看药物接收、库存表、药物出入库记录和研究中心处方单或药物分配信息报告等记录文 件，与药物实际库存进行比对，确保药物实际使用情况、库存情况与文件记录一致；

• 核查药物配制与注射表，确认是否按照方案和说明书要求进行配置，配制后药物保存过程， 实际注射过程是否与方案和说明书要求保持一致，如出现药物剂量调整或未完全注射规定 剂量等特殊情况出现，需确认在原始记录中是否完整记录整个过程；

• 核查药物在运输过程中药物温度情况是否符合方案、说明书要求，一旦发现超温需要立即 按照规定流程上报（详见研究药物管理计划）；

• 检查药物储存设备及温度计的性能，运转情况，设备校准效期符合要求；如发现异常的温 度记录也需要先排查温度计是否异常，并申请备用温度计。

关键流程要点（结合 SOP-CO-2005《试验用药品的管理及监查》）

• 启动前：确认药物手册和 IRT 手册（如适用）已随试验文件送达中心；双盲试验须在研究者或授权人员证明具备紧急揭盲能力（已收到揭盲信件或 IRT 揭盲权限已测试通过）后方可发药至中心；

• 启动访视：核对到药及储存情况，完成药物手册、IRT 操作（接收、发放、回收、库存状态更新）以及超温、投诉等药物问题处理流程的培训，所有培训均须留存记录；

• 库存与补给：监查时核对 IRT 系统中药物状态（发放、隔离、拒收）准确并及时更新，确认自动补给机制正常触发，确保中心始终有充足的研究药物供应；

• 超温管理（关键）：超温事件须在发现后 24 小时内使用《研究中心超温报告表》（SOP-CO-2005-R01）上报；受影响药物立即物理隔离并在 IRT 中置为隔离状态，在申办方 QA 出具“批准继续使用”或“召回”结论前不得使用；CRA 按方案偏离计划评估是否将该事件录入 CTMS，并与中心药物管理员确认是否需要紧急补给；若试验参与者已使用被判定为不适合使用的药物，须立即由 CPM/授权人按 QA 要求上报；

• 有效期管理：关注药物有效期/复检日期延长通知，及时核对中心库存药物标签及 IRT 中有效期信息的更新情况；

• 清点与销毁：销毁或退回前必须完成现场清点核对（接收-发放-回收-库存平衡）；经批准在中心销毁的，确认销毁过程合规并将销毁证明存档于研究者文件夹；不允许现场销毁的中心，清点完成后协助将药物退回仓库销毁；

• 文件存档：药物相关记录（运输单、温度记录、库存分发日志、配制输注记录、清点记录、销毁证明等）均属必要文件，须保存于 ISF/TMF。

CRA 监查技巧与要点

• 清点平衡公式：接收总量 = 已发放 + 当前库存 + 已回收/销毁/退回，逐项核对 IRT 数据、库存分发日志与实际实物三者一致；

• 温度记录连续性：核查温度记录无断档（含节假日），发现超温时段须对应有超温报告及处理结论，温度曲线与药物批次进出库时间的逻辑吻合；如发现异常温度记录，先排查温度计是否异常，必要时启用备用温度计；

• 盲态保护：盲法试验监查时注意不接触非盲信息，确认非盲药物管理及非盲监查安排符合项目要求（如适用）。

情景题

【情景】常规监查时，你发现 2-8℃药房冰箱在周末夜间温度升至 10.5℃并持续约 8 小时（方案要求 2–8℃），温度记录单上有记载，但药品管理员既未填写超温报告也未隔离药物，且周一早上已从该批药物中发放 1 盒给试验参与者 03-012 并完成给药。作为 CRA，你如何处理?

【解决步骤】

1. 立即隔离与补报：当场要求中心立即将剩余受影响药物物理隔离并在 IRT 中置为隔离状态、暂停发放；督促药品管理员自发现起 24 小时内补填《研究中心超温报告表》上报申办方；

2. 试验参与者安全优先：因受影响批次的药物已被试验参与者使用，第一时间报告 PM 和医学人员，由医学评估对试验参与者 101001 的潜在安全风险，必要时安排额外安全性随访；*并按 QA 要求上报“试验参与者使用了可能不适合使用的研究药物”事件（根据项目要求）*；

3. 等待质量结论：在申办方 QA 完成超温评估并出具“批准继续使用/召回”结论前，确保受影响批次全程保持物理和 IRT 双重隔离，不得使用；

4. 记录偏离与 CAPA：将“超温未及时上报、未隔离、隔离前发放”记录为方案偏离（试验药物重大管理错误属重要方案偏离），录入 CTMS；协助中心进行根本原因分析（如药品管理员对超温流程不熟悉、冰箱报警失灵），完成再培训并留存记录，必要时排查冰箱设备并启用备用温度计/备用冰箱；

5. 保障供应：与 SIC 确认是否需要紧急补给新批药物，避免影响后续试验参与者用药；

6. 跟进闭环：跟踪超温评估结论、CAPA 执行情况及有效性，在监查报告和跟进函中完整记录，并在下次访视复核整改落实情况。

3.5 不良事件/严重不良事件的监查要点

3.5.1 定义

不良事件（AE）：是指试验参与者接受试验用药品后出现的所有不利的医学事件。不良事件不一定与治疗有因果关系；不良事件可以是原有症状、体征、实验室异常的加重，或新诊断的疾病、有临床意义的实验室异常值等。

严重不良事件（SAE）：在任何剂量下出现的被认为是严重的不利的医学事件，满足以下任一判定标准：导致死亡、危及生命、需要住院治疗或者延长住院时间、导致永久或者严重的残疾或者功能丧失、先天性异常或者出生缺陷；对于虽然可能不会立即危及生命、导致死亡或住院，但可能损害试验参与者或可能需要干预以防止严重后果发生的重要医学事件，通常应被视为严重不良事件。

3.5.2 总体监查原则

试验启动会后，监查员在监查访视中，需逐一对每位试验参与者的不良事件、严重不良事件进行全覆盖核查，确认所有 AE/SAE 的识别、记录、评估、处理、上报流程均严格符合法规、试验方案、项目 SOP 法规要求

3.5.3 AE 整体监查核心要求

1. 诊疗与处理及时性监查

监查过程中需重点核查试验参与者发生不良事件后的诊疗情况，确认试验参与者是否获得及时、规范的对症诊疗；核查研究者对不良事件的处置及时性、随访频次是否合理，是否根据 AE 严重程度、试验参与者病情变化开展持续追踪、复查评估，保障试验参与者试验参与者安全。

2. 记录及时性与规范性监查

核查研究者是否在获知不良事件后及时完成记录，避免延迟补记、事后集中补填情况；严格核查 AE 记录信息的完整性、准确性、真实性，确保所有记录贴合参与者实际病情，无遗漏、无篡改、无虚假信息。

AE 记录需同步于事件获知时间，事后大批量补记录属于核查高风险项。

3. 记录来源全覆盖监查

监查前需督促研究中心完整备齐相关溯源材料，监查过程中全面核查各类原始数据源，确保无 AE 遗漏。

核心溯源来源包含：试验参与者日志卡、研究相关问卷；研究医生、护士通过问诊、查体、护理记录及实验室检查结果、研究病历、病程记录；院内各科室、外院的检查报告、诊疗记录、住院及门诊病历等全部相关资料。

监查重点关注：试验参与者外院就诊信息，为 AE 漏报高发点；需要主动溯源，不能仅依靠试验参与者主动告知。

4. AE 关键信息要素监查

严格核查每例 AE 的核心记录要素，确保信息完整、逻辑合规、填写规范，关键要素核查要求如下：

- **AE 名称**：优先填写明确的医学诊断，无法明确诊断时，可填写具体症状或体征，注意翻译使用专用版工具。
- **AE 级别**：严格依据方案指定标准（如 CTCAE 标准）进行严重程度分级评估，并完整准确记录分级结果。

- **起止时间**：AE 开始时间以症状首次出现、相关异常体征发现或疾病确诊日期为准；结束时间以症状痊愈、病情状态稳定、异常结果得到合理解释或试验参与者失访日期为准。起止时间均需精确到年月日，且需留存对应的检查报告、诊疗记录、诊断证明等原始溯源文件存档。
- **AE 转归**：严格遵循项目 CRF 填写要求记录，常规包含痊愈、好转 / 缓解、未好转 / 未缓解 / 持续、痊愈伴后遗症、致死、未知等结局类型，确保结局与随访病历、复查结果一致。AE 需要持续随访至结局明确，不因试验参与者提前退出试验终止随访。
- **相关性评估**：严格按照方案规定的评估标准（如五分法：肯定有关、很可能有关、可能有关、可能无关、无关）完成评估记录。监查员需重点核查相关性判断的合理性，结合 AE 发生时间、试验参与者基础疾病、合并用药、试验用药暴露情况综合研判，若发现评估结论明显不合理，需及时对接项目组、医学经理沟通核实。
- **合并治疗及试验用药处理**：完整记录 AE 发生期间的所有合并用药、对症处理措施；需记录试验用药品的处置情况，参照 CRF 要求填写，如剂量不变、延迟用药、剂量减少等。注意避免忽略非药物治疗。
- **特殊字段核查**：按项目 CRF 要求核查特殊字段填写情况，重点确认是否标注 SAE、AESI、输液反应、过敏反应等特殊不良事件分类信息，确保特殊事件分类准确、无遗漏标注。
- **3.5.4 SAE 专项监查要点**

  1. 事件识别与筛选监查

  监查员需重点甄别所有不良事件，核查符合 SAE 判定条件、符合特殊关注不良事件（AESI）标准的事件，确认研究者无漏报、晚报情况。

2. 上报流程与及时性监查

核查研究者是否严格遵循中心 SOP 流程及项目组上报要求，及时完成 SAE 上报。确认研究者在获知 SAE 后，立即向申办者、伦理审查委员会提交书面报告；

3. 试验参与者救治情况监查

重点核查发生 SAE 的试验参与者是否第一时间获得规范、有效的医疗救治，研究者急救处理、对症治疗、后续随访诊疗措施是否及时、合理、完整，充分保障受试验参与者安全。

4. 上报资料规范性监查

核查 SAE 上报全流程资料完整性与规范性：确认上报对接人员、对接部门准确齐全；上报邮件、递交回执、沟通记录完整存档；SAE 报告使用版本为项目最新有效版本；报告所有内容与原始病历、检查报告、诊疗记录完全一致，符合法规要求及项目 SOP 规定。

5. 报告全周期管理监查

核查 SAE 报告闭环管理情况，确认研究者已按要求提交首次报告、随访报告及总结终报告，事件全程动态更新、信息同步完善；核查 PV（药物警戒）质疑是否及时接收、核实、回复，无超期未处理质疑。

6. SUSAR 流程合规性监查

结合 SAE 事件信息，核对事件是否符合 SUSAR（可疑且非预期严重不良反应）判定标准（SAE + 与试验药存在合理可能性相关 + 非预期，超出研究者手册 IB 描述）；确认符合条件的 SAE 已按法规要求进行 SUSAR 上报。

3.5.5 整体监查闭环要求

监查过程中发现的 AE/SAE 记录缺陷、流程问题、数据偏差、上报违规等问题，需及时出具监查质疑，督促研究者限期整改、补充完善、留痕记录，全程跟踪整改闭环，确保所有安全

性数据满足 ALCOA + 原则，真实、完整、准确、合规，保障临床试验安全性数据质量与试验参与者权益。

Q 签署知情同意书后，入组前发生的异常医学事件是否需要记录不良事件?

A 根据定义不良事件发生在给予试验用药物之后，但临床试验中关注广泛的安全性信息，通常签署知情同意书后即需要开始收集安全性事件，在签署知情同意书后筛选期内，试验参与者因为研究的流程如采血等操作导致的异常的医学事件，需要被记录为不良事件；

Q 试验过程那些资料记录的不良事件容易被漏记?

A 院内护理记录、出入院记录记录的异常情况容易被研究者忽略；参与者外院、外科室的就诊记录的异常情况未及时收集，导致不良事件的漏报；或照搬外科室外院诊断，未结合参与者实际情况、方案情况记录，如发现需提醒研究者参考 GCP、方案等要求及时规范记录；

Q 如果参与者死亡，不良事件结果应如何记录?

A 主要参考项目组 CRF 填写指南要求进行记录，

常规分 2 种情况，如该 AE 导致参与者死亡，则该 AE 结局则为死亡；如果该 AE 不是导致参与者死亡的原因，则结局为持续；

Q 择期手术、方案规定的计划性住院或考虑便利性如医保报销等原因住院，属于 SAE 吗?

A 计划性入院（择期手术、方案预设访视住院、单纯给药住院）不属于 SAE。**Q 参与者提前退出试验，还要持续追踪已发生 AE/SAE 直到结局吗?**

A 需要继续跟踪。所有 AE/SAE 必须随访至稳定、恢复、结局明确或失访，不能因为试验参与者出组就停止追踪。

Q SAE 上报时限是多久?

A ICH E6 (R3)+ 中国版 GCP 均描述研究者获知 SAE，应立即报告申办者及伦理委员会；

未规定明确时间，具体时间中需参考中心、项目组要求，常规要求研究者应当在获知 SAE 后 24 小时内报告申办者、伦理委员会。需注意核对原始记录，报告表记录获知时间是否真实。

3.6 合并用药的监查要点

3.6.1 定义:

合并用药/治疗（CM）是指在临床试验期间，参与者除了接受试验药物 / 试验干预措施以外，同时使用的其他所有药物、治疗；

3.6.2 分阶段监查要点

1. 筛选期

- 核对源文件：门诊病历、既往处方、购药记录、检验单，确认**筛选窗口期用药**，核查是否存在方案规定的**禁用药物**
- 核查停药洗脱期：若方案要求特定药物洗脱（如免疫抑制剂、抗凝药、某些化疗药），核对**停药日期、入组日期**，确认洗脱时间满足方案要求；
- 基线合并用药采集完整度：所有正在使用药物，记录：通用名、商品名、剂量、给药途径、给药频次、开始日期、停止日期、用药原因
- 评估：合并用药是否会干扰试验药安全性 / 有效性终点；是否存在药物相互作用风险；**如涉及违禁用药需上报方案偏离**；

2. 试验治疗期（给药后至末次给药）

- 源数据溯源：病历、处方、药房记录、试验参与者日记卡；**CRF/CM 表必须与原始病历一致**
- 区分：

- 长期基础用药（高血压、降糖药）：记录持续使用，剂量变化需更新记录，评估是否为 AE 诱因
- 新启用药物：必须记录**用药原因**，判断是基础疾病、AE、其他疾病；**新用药和 AE 做关联**
- 临时用药、短期抗生素、止痛药：全部录入 CM，不可省略（配液、造影剂等无需记录）

- 方案限制用药：方案规定慎用 / 限制使用药物，一旦使用，核查是否符合方案允许条件、是否记录理由、是否通知项目组；

3. SAE/AE 发生时的合并用药核查；

SAE/AE 发生**前后的合并用药变化**，用于因果关系评估

1. 提取 SAE 发生时间点前后用药清单：事件发生前 2 周 / 方案规定窗口期用药、SAE 发生后新增治疗用药
2. 核查：
   - 治疗用药是否完整记录，关联到对应 AE/SAE
   - 是否存在新启用合并用药，有可能作为 SAE/AE 的诱因（如抗生素导致过敏、抗凝药致出血）
   - 合并用药起始 / 停止时间逻辑合理（时间线核对）
3. 研究者因果评估溯源：研究者评估 AE/SAE 与试验药相关性时，是否充分考虑合并用药作为替代原因；

4. **末次给药后 / 安全性随访期**

- 安全性随访期内新使用药物，**仍需要记录合并用药**（安全性观察期内，AE/SAE 仍需追踪）
- 出组不等于停止采集 CM，需参考方案要求：随访电话记录中询问用药变化，电话记录作为源文件；

3.6.3 数据字段监查核对清单（CM 表单 / CRF 字段）

每条合并用药，源数据 & CRF 必须核对：

1. 药物**通用名**（涉及英文翻译使用专业版翻译）
2. 剂量、给药途径、给药频率
3. **开始日期 / 停止日期**
4. **用药目的**（基础疾病、AE、预防用药等，需核对用药目的符合药物基本适应症）
5. 用药状态：正在使用 / 已停用
6. 关联 AE（如果用药是针对某个 AE，则建立关联）
7. 所有合并用药信息**源数据可溯源**

3.6.4 监查行动项 & Query 策略

1. 源数据不一致：病历处方 与 CRF CM 表不一致 → 发 Query，研究者溯源原始记录，修改留痕

2. 信息缺失 Query：一次性列出缺失字段，要求研究者查阅病历 / 询问试验参与者补全；
3. 时间线矛盾：提醒研究者核对用药、AE、访视时间，澄清时序
4. 发现方案禁用药物：立即上报申办者，评估试验参与者是否需要退出研究，完整记录事件经过

Q1：试验参与者在其他医院开的药，研究者不知道，CRA 怎么处理?

A：监查时主动查阅外院病历、检验、试验参与者日记；发现未记录用药，告知研究者评估，补充录入 CM，记录溯源过程。

Q2：合并用药停药，需要填写停止日期吗?

A：是的；持续使用到末次随访，停止日期填 “持续”。

Q3：同一药物多次调整剂量，怎么记录?

A：需参考 CRF 要求，常规新增一条记录，区分不同剂量时间段；

3.7 安全性报告提交，递交常见问题

安全性报告：SAE/药物过量/妊娠事件/SUSAR

- 不良事件收集从试验参与者签署知情同意书（在进行任何研究相关程序和/或接受研究药物之前 签署）开始，直至末次研究药物给药后 42 天（±7 天）（安全性随访期）或至试验参与者开始 新的抗肿瘤治疗前，以先发生者为准；
- 使用项目组提供的严重不良事件报表模板；
- 核查发生的所有严重不良事件均已报告申办方（或指定人员）；
- 核查所有严重不良事件均已按照中心要求以书面形式报告给 IRB/IEC。所有 SAE 均已记录 在 eCRF 不良事件页。如果严重不良事件还在随访，将在每次后续访视时评价关注。；
- 确认原始文件中发现的所有新的不良事件均已记录在 eCRF 上；
- 确认任何新的不良事件相关的特殊备注也均已记录在 eCRF 的不良事件部分；
- 确认每次未结束的不良事件或者严重不良事件在后续访视中，研究者需要继续评估并跟踪 到不良事件结束或者稳定；
- 确保在研究结束时对正在进行的 AE 进行充分随访，直至消退或者 PI 认为不再需要随访。

关键报告时限（2026 版 GCP / ICH E6(R3)要点）

• SAE：研究者应在获知后立即、最迟不超过 24 小时向申办者书面报告，并按中心要求报告伦理委员会和临床试验机构；首次报告信息不全时可先报告已知信息，随后及时提交随访/总结报告；

• SUSAR：申办者快速报告时限——致死或危及生命的 SUSAR 为首次获知后 7 天内报告，并在随后 8 天内完善随访信息；其他 SUSAR 为首次获知后 15 天内报告；本中心 SUSAR 由研究者签收审阅后及时递交伦理委员会和机构，外院 SUSAR 按伦理委员会要求定期汇总递交；

• 妊娠事件：试验参与者或其配偶发生妊娠时，按 SAE 同等时限和要求填写妊娠事件报告表上报申办方，并随访至妊娠结局（含新生儿情况）；

• 药物过量：无论是否伴随不良事件，均应按方案规定的时限和要求记录并报告申办方，同时评估是否构成方案偏离；

• DSUR：研究者每年接收并签收申办者提供的研发期间安全性更新报告，并按中心机构和伦理要求递交备案/审查。

CRA 监查技巧与要点

• 三方一致性核对：SAE 报告表、eCRF 不良事件页、原始病历（病程记录、出院小结、检验检查报告）之间的事件名称与 CTCAE 分级、起止日期、严重性、因果关系判断、转归必须一致；发现不一致时先与研究者确认，再由研究人员更正并留痕；

• 时限核查技巧：以“获知时间”为起点核对 24 小时上报是否达标——获知时间以研究者或研究团队首次知晓为准（如试验参与者电话告知、外院急诊记录），而非病历书写时间；

• 完整性反向溯源：从住院记录、急诊记录、合并用药变化、显著检验异常值中主动排查是否存在漏报的 AE/SAE/irAE/特殊关注不良事件，而非仅核对已上报的事件；

• 回执与签收：确认 SAE 等事件递交伦理/机构/申办方 PV 的回执、申办方 SUSAR 报告的签收记录均保存于 ISF，递交日期符合中心 SOP 及伦理要求时限；

• 随访闭环：未结题的 SAE/AE 在每次访视时持续追踪，确认研究者评估至事件消退、稳定或失访（失访须有随访努力记录）。

情景题

【情景】监查访视中，你发现试验参与者 101001 两周前因“3 级间质性肺炎”住院治疗，病程记录中有明确记载，但研究者既未向申办方上报 SAE，eCRF 不良事件页也未录入。研究者解释：“以为是原疾病进展，不算不良事件。”作为 CRA，你如何处理?

【解决步骤】

1. 立即行动：当场告知研究者该事件符合 SAE 标准（导致住院），因果关系判断不影响报告义务——是否相关由研究者评估，但上报义务不能免除；协助研

究者尽快（补报亦应遵循 24 小时原则）完成 SAE 首次报告，上报申办方、伦理委员会和机构，并让 CRC 补录 eCRF 不良事件页；

2. 记录偏离：将“SAE 迟报/漏报”记录为重要方案偏离，录入 CTMS/方案偏离日志，并报告 PM 和医学人员；

3. 根因分析与 CAPA：协助中心进行根本原因分析（研究者对 SAE 定义及因果关系判断存在理解偏差），对研究团队进行 SAE 识别与上报流程的再培训并保留培训记录；与 PM 讨论是否需要提高该中心的监查频率或增加针对性支持；

4. 扩大核查：对该中心其他在组及已出组试验参与者的住院、急诊记录进行反向溯源，确认无其他漏报事件；

5. 跟进闭环：持续随访该 SAE 至转归，确认随访/总结报告及时递交；在监查报告和跟进函中完整记录该问题、整改要求和时限，并在下次访视复核 CAPA 有效性。

4. 临床试验监查过程中的沟通 Tips

4.1 与研究中心人员的沟通

临床试验监查过程中的沟通 Tips

1 法规锚点（沟通的依据）

- 职责明确并留痕：医学判断与医疗决策必须由有资质的临床医生做出（第八条）——"什么事找谁"的根本依据；
- PI 是现场最终责任人，对受试者权益、安全和试验质量负责（第十九条）；PI 的临床试验决策、关键确认及对伦理/机构/申办者的正式报告原则上不得授权（第二十条）；
- PI 获知 SAE 后应立即书面报告申办者和伦理（第二十六条）——漏报、迟报是沟通最高优先级事项；
- PI 和机构有义务接受监查、稽查与药监检查并配合提供记录（第三十一条）——沟通遇阻时的合规底线（宜作底线，不作开场白）；
- 申办者应建立有效沟通渠道并记录关键沟通内容（第三十四条）——重要事项口头沟通后务必书面跟进；医学问题转申办方医学人员，CRA 不自行解释；
- 监查是申办者主要质量控制活动（第四十一条）；不依从须纠正，可能显著影响权益/安全/数据可靠性的不依从，应分析根因、采取 CAPA 并书面报告伦理（第四十三条）。

2 沟通时机与内容

1、 离场沟通：监查结束后，就发现问题与研究者、药品管理员、CRC 等当面讨论解决方案；

2、 入组期沟通：分析筛选失败常见原因，评估潜在受试者来源，与研究者讨论；

3、 前瞻性提醒：重要节点（关键肿瘤评估、PK 采样）与易忽略细节（合并用药禁忌）提前提醒；

4、共识落实：明确整改事项、责任人（落实到具体人员）和完成时限。

3 通用沟通原则

- 专业先行：熟悉方案、知情同意书、研究者手册和法规再开口；
- 对事不对人：说客观事实与影响（"V2 超窗 2 天"），不评价人（"你们总是拖"）；
- 分级处理：一般问题现场口头提醒；反复或重要问题书面化，纳入监查报告跟踪 CAPA 闭环；
- 不越权：可提示方案要求与记录规范，不指导诊疗、不代做医学判断；
- 保密：不在受试者面前讨论其试验信息，不泄露盲态及其他受试者信息；
- 守时守约：预约访视、提前发送确认函和待办清单，尊重中心临床节奏。

4 记录与闭环

- 重要事项口头沟通后，以邮件/随访信书面确认（符合第三十四条，也是稽查检查证据）；

- 离场共识逐项登记整改事项、负责人、完成时限，下次访视逐一核对关闭，形成 PDCA 闭环；
- 重要安全性信息、方案修订经正式渠道传达，留存递交与签收记录。

5 分对象沟通

（一）与 PI——抓大放小、就高优先：

- 访视前发议程，把时间留给：入组进度与筛选失败分析、重要方案偏离定级与 CAPA 确认、SAE/SUSAR 签阅、关键文件（伦理/进展报告）签署；
- 沟通结构化：问题清单+依据+建议措施+需要 PI 做的事，一页纸说清；
- 配合度低时先化解"怕麻烦"：说明签字/报告迟延可能构成不依从并触发书面报告伦理的后果，讲利害而非施压。

（二） 与 Sub-I、研究护士、药师、机构办——培训式、支持式：

- 启动初期多花时间培训流程与易错点（授权分工、源文件记录规范、药品管理记录），"教一次"胜过"查十次"；
- 带具体法规/方案条款沟通：护士关注 AE 观察记录、随访窗口、样本采集时限；药师关注接收、储存温度、发放回收与计数一致性；
- 机构办事项：立项、伦理递交、检查配合——礼貌、提前、资料一次备齐。

4.2 与 CRC 的沟通

与 CRC——双向赋能、守住红线：

- 定位：CRC 经 PI 授权，属研究中心侧，可协助事务性工作（填 CRF、随访协调、资料整理），不能做医学判断、不能替代 PI 决策或签署医学文件（第八、二十、二十五条）；
- 事务找 CRC：随访提醒、query 回复、检查预约、表格自查、归档进度——高效批量处理；
- 红线升 PI：方案偏离确认定级、AE/SAE 漏报、知情同意瑕疵、入排疑问——不能只跟 CRC"说清楚"，须推动与 PI 直接确认并书面留痕（正式上报原则上不得授权，必须 PI 本人完成）；
- 双向赋能：提供方案更新摘要、易错点清单、访视 checklist，减少对立感；
- 警惕角色混淆：CRC 多由 SMO 派驻，避免让其替申办者"催"研究者做不合规的事，注意利益冲突回避（第十二条）；发现越权（自行解答医学疑问、代签日期）应礼貌制止、培训，必要时报告 PI 和机构；
- 统一口径：重要告知（方案修订、安全性信息更新）须经正式渠道（研究者会议、文件递送）传达，"跟 CRC 说了不算"。

5. 监查报告的完成与提交

报告提交/定稿时限

根据 SOP-CO-2006 Management of Monitoring Report and Follow Up Letter 提前与研究中心预约，发送访视确认函。按照监查计划、方案和 SOP 执行监查活动，完成 监查访视记录。每次监查访视后在 5 个工作日完成监查报告，经 CPM 审核后 10 个工作日归档。针对发现的问题发送跟进函并与研究者报告，明确整改要求和时限，并在下次访视时复核整改情况。 监查频率的制定依据研究中心试验参与者的入组数、数据的质量、eCRF 录入的及时性、SDV 的比例和研究中心的表现状态，结合项目层面的规定来制定。

确认监查日期后，建议在日历/形成中添加报告撰写时限的提醒，在计划日期内完成提交，CRA 应按照项目组要求提前在 CTMS 中按照监查计划预定自己的访视。

报告撰写要求

- 按照项目特定的指南完成报告
- 内容描述：**言简意赅**

要具体/准确✓	不要笼统/模糊 X	使用 5W1H 记录： Who，What，When, Why, How 明确时限， 避免使用“尽快” 描述具体文件时注明版

		本号和版本日期； 不同的问题分条进行描述，使用具体数字，不用“大部分、一些”等模糊描述。
要客观✓	不要主观 X	建议用第三人称书写，陈述客观事实，不带主观偏见。
简洁，切中要点✓	重复记录、拼写错误 X	避免使用不常见/有歧义的缩写； 不重复记录已在别处追踪的信息（如 EDC 质疑）
按照指南填写记录✓	直接复制其他报告 X	避免直接复制上一次报告或其他中心报告进行修改，需确认指南的内容均已如实记录
更新当前信息✓	未记录已采取措施 X	在监查报告定稿前，已与项目组人员讨论的问题，记录监查后已采取措施/更新记录相关信息

6. 问题的跟进与管理

发现问题，收集信息

哪些是问题：已经发生的、不遵从方案/SOP/法律法规/相关指导原则/项目特定要求的，对试验/试验参与者产生负面影响的问题等

再监查，质控，稽查或日常沟通/管理发现问题后，与研究人员合适问题内容，了解收集相关信息：发生时间，问题发生过程，原始记录，试验参与者/相关人员/药物目前的情况等

分析问题

将复杂的问题细分后逐一分析：

1）频率：单次还是多次发生

2）影响范围：涉及 1 个试验参与者还是多个

3）根本原因分析，常见方法如下：

-开放式提问：着重于问题发生的过程进行询问（比如：你具体是如何操作的？为什么要按照这个方式进行？科室/机构对这个流程有什么要求）

-5Why：从结果着手，连续询问多个为什么，按照因果逻辑关系，层层询问直至找到问题根本原因

-鱼骨图

问题记录与上报

1）记录：将问题记录再 CTMS 中（描述问题&计划解决措施，内容简明扼

要，明确责任人，注明计划解决时限)。注意撰写监查报告时，将问题添加到把报告中

2）上报：

按照项目组要求及时上报，不确定/潜在问题及时与项目组沟通

质量问题需要采取行动的质量问题必须按照 SOP 要求进行上报

严重问题（critical)：适用于当稽查问题被认为对试验参与者权益、安全或健康，和/或临床试验或试验数据的质量和真实可靠性造成不利的影响。即使每个稽查问题都不是“严重”问题，多个“重要”问题的集合可能被归类为一个“严重”的系统性稽查问题。

重要问题（major)：适用于当没有被适当的管理，稽查问题对试验参与者权益、安全或健康，和/或临床试验或试验数据的质量和真实可靠性有可能造成不利的影响。即使每个稽查问题都不是“重要”问题，多个“一般”问题的集合可能被归类为一个“重要”的系统性问题

一般问题（minor)：适用于对质量管理体系和/或 GCP 原则的偏离，但该情况、操作或过程的偏离对试验参与者权益、安全或健康和/或临床试验或试验数据的质量和真实可靠性均没有不利的影响。

解决&关闭问题

1）时限

需要按照 SOP 和/或项目组要求及时关闭问题

2）纠正和预防措施（CAPA）

- CAPA 包括：Corrective Action 纠正措施、Preventive Action 预防措施
- CAPA 计划中，每项措施需要包含负责人及计划完成日期
- CRA 应确保之前访视中发生的问题再后续访视中得到妥善解决
- 质量问题：需要确保所有要求的措施已经完成，且相关的沟通和客观依据已被适当录入到系统中

3）关闭问题

CRA 应确保所有问题和采取的行动都记录在监查报告中

只有当每一个纠正措施真正有效地实施并经核实确认，或者确定不可能采取其他纠正措施时，才能关闭该问题。

参与人员

编辑人员

任金辉 Susan Ren

蒋亚南 Yanan Jiang

李燕云 Yanyun Li

陈勇强 Yongqiang Chen

谢钰镜 Yujing Xie

黄璐 Lu huang

张思远 Siyuan Zhang

核对人员

任金辉 Susan Ren

封面设计

任金辉 Susan Ren

为了帮助大家更加高效的提高监查技能，我们总结了以下指南供大家参考。

序号	文件名称
1	临床中心（含美国临床，用于 SOP 发布） - SOP-CO-2004 研究中心的筛选访视 Pre-Study Visit-V01-CN&EN-20241225 生效.pdf - 所有文档
2	内部 CRA 培训-2026 年度培训
3	内部培训-适用于 CRA Trainee&CRAI
4	ICH_E6(R3)_Step4_FinalGuideline_2025_0106.pdf
5	Good Clinical Practice
6	SIV checklist
7	监查 checklist

